



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN TRIWULAN II
KOMITE PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN INFEKSI
TAHUN 2026**

I. SDM

1.1 Ketenagaan (Kebutuhan dan Distribusi Tenaga, Kualifikasi Tenaga).

1.1.1 Kebutuhan SDM dan Distribusi Tenaga.

Tabel 1.1.1 Kebutuhan dan distribusi tenaga.

Jabatan	Jumlah SDM			Keterangan
	Standar	TW II 2026	Kebutuhan	
IPCO	1	1	0	
IPCN	1	1	0	1 purna waktu
IPCLN	17	17	0	IPCLN merangkap kegiatan pelayanan pasien
Maternitas	1	1	0	
Gizi	1	1	0	
IPSRS & K3RS	1	1	0	
CSSD	1	1	0	
Laundry	1	1	0	
Cleaning Service	1	1	0	
Petugas Kamar Jenazah	1	1	0	
Laboratorium	1	1	0	
IFRS	1	2	0	1 Gudang Farmasi, 1 Pelayanan Farmasi
Instalasi Rekam Medis	1	1	0	
Asuransi Center	1	1	0	
Radiologi	1	1	0	

1.1.2 Pemenuhan Kualifikasi SDM.

Tabel 1.1.2 Pemenuhan Kualifikasi SDM.

Jabatan	Pendidikan		Sertifikasi						Keterangan
	Standar	Kondisi bulan ini	PPI dasar	PPI lanjut	PPI starkes	IPCN	IPCN lanjut	PPI TOT	Isi yg berhubungan dg PPI
IPCO : dr. Aida M, Sp.OG	Dokter	Dokter	+	-	+	-	-	-	
IPCN: Sherly Rosita, S. Kep, Ns	S1	S1	+	-	+	+	-	-	

Jabatan	Pendidikan		Sertifikasi						Keterangan
	Standar	Kondisi bulan ini	PPI dasar	PPI lanjut	PPI starkes	IPC N	IPC N lanjut	PPI TOT	Isi yg berhubungan dg PPI
IPCN : Lusianah Nurul I AMd. Kep	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	Sudah pelatiha n ekstern al PPI dan IPCN dasar
Rismaya Felantri A, S. Kep. Ns	Min. D3	S1	+	-	-	-	-	-	
Neni N, AMd. Kep	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
Eko Pambudi, Amd. Kep	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
Yuni Novita, AMd. Kep	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
Raysa R, AMd. Kep	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
Purwinda Respati P, AMd. Kep	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
Tri Ani Darma, AMd. Kep	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	Sudah pelatiha n ekstern al PPI dasar
Resa Novitasari, Amd.Kep	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
Anis N. S. Kep. Ns	Min. D3	S1	+	-	-	-	-	-	
Tatik Widayati, S. Kep. Ns	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
Uswatun Chorida, AMd. Keb	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
Laras Wieny, Amd. Kep	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	Sudah pelatiha n ekstern al PPI dasar

Jabatan	Pendidikan		Sertifikasi						Keterangan
	Standar	Kondisi bulan ini	PPI dasar	PPI lanjut	PPI starkes	IPC N	IPC N lanjut	PPI TOT	Isi yg berhubungan dg PPI
Diyah Purwanti, S. kep. Ns	Min. D3	S1	+	-	-	-	-	-	
Wahlah, S. Kep. Ns	Min. D3	S1	+	-	-	-	-	-	
Indha Maghfirotin, AMd. Kep	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
Ns. Firda Ayu Maghfiro, S. Tr. Kep	Min. D3	D4	+	-	-	-	-	-	
Tiara Anggita Putri, S. Tr. Kep. Ns	Min. D3	D4	+	-	-	-	-	-	
Trikaya Inggar Yuniar, AMd. Kep	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
Gizi : Ericha Risdawati, Amd .GZ	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
IPSRs & K3RS : Elzada Sofi AMd. Kes	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
CSSD: Taufan, Amd. Kep	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
Laundry: Nur Hidayat	Min. SMA	SMA	+	-	-	-	-	-	
Cleaning Service: Putri Wahyuning Gusti	Min. SMA	SMA	+	-	-	-	-	-	
Laborat: Yoga Mada A, Amd. AK	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
IFRS : Yuanita eka, S. Farm. Apt	Min. D3	S1	+	-	-	-	-	-	
IFRS : Gadis Arivia, S. Farm. Apt	Min. D3	S1	+	-	-	-	-	-	

Jabatan	Pendidikan		Sertifikasi						Keterangan
	Standar	Kondisi bulan ini	PPI dasar	PPI lanjut	PPI starkes	IPC N	IPC N lanjut	PPI TOT	Isi yg berhubungan dg PPI
Radiologi: Erwin Prasetyo Aji, Amd. Rad	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
RM: Nurmayanti Sekar Wulan, AMd. RMIK	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
Asuransi Center: Ayu Lestari F.NR, AMd.Aktr	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	

- 1.2 Orientasi
- Orientasi umum:
- Orientasi umum: dilakukan orientasi kepada dokter umum baru sebanyak 1 orang pada tanggal 18 Mei 2026.

- 1.3 Pendidikan dan Pelatihan
- Dilakukan Pelatihan IPCN dasar pada bulan ini yaitu tanggal 8 April 2026 – 12 April 2026 di Kampi Hotel Surabaya
 - Dilakukan Pelatihan PPI dasar pada bulan ini yaitu tanggal 19 Mei 2026 – 23 Mei 2026 melalui zoom meeting.

- 1.4 Evaluasi Kinerja
- IPCLN dan anggota komite PPI lainnya secara keseluruhan sudah menjalankan tugasnya, namun masih ada beberapa petugas yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik setiap bulannya dan menunggu ditegur terlebih dahulu. Dari proses pemenuhan tugasnya diperoleh prosentase sebanyak:

Kategori Nilai	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
A/Sangat baik (91-100%)	3	3	5	4	5	3						
B/Baik (81-90%)	4	4	12	14	11	7						
C/Cukup (71-80%)	9	10	5	8	7	5						
D/Kurang (61-70%)	4	4	4	1	4	8						
E/Sangat Kurang (<61%)	7	6	2	1	1	5						

(Lampiran evaluasi IPCLN/Anggota Komite PPI lainnya per nama)

Analisa: Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian terhadap 27 unit setiap bulan selama periode Januari sampai Juni, terlihat adanya perubahan capaian mutu yang cukup dinamis pada setiap kategori penilaian.

Pada bulan Januari, sebagian besar unit masih berada pada kategori C (9 unit) dan E (7 unit), sedangkan unit yang memperoleh kategori A hanya sebanyak 3 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada awal tahun masih terdapat cukup banyak unit yang belum memenuhi standar yang diharapkan sehingga memerlukan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut.

Memasuki bulan Februari, perubahan yang terjadi belum terlalu signifikan. Jumlah unit kategori A dan B tetap sama dengan bulan sebelumnya, sedangkan kategori E mengalami sedikit penurunan dari 7 unit menjadi 6 unit, yang menunjukkan mulai adanya perbaikan pada beberapa unit.

Perbaikan yang cukup nyata mulai terlihat pada bulan Maret hingga Mei. Jumlah unit dengan kategori A meningkat menjadi 5 unit, sedangkan kategori B meningkat tajam dari 4 unit menjadi 12 unit pada Maret dan mencapai 14 unit pada April. Pada periode yang sama, jumlah unit dengan kategori E menurun drastis menjadi hanya 2 unit pada Maret dan 1 unit pada April serta Mei. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan monitoring, supervisi, sosialisasi, maupun tindak lanjut yang telah dilakukan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan unit terhadap standar yang dinilai.

Namun demikian, pada bulan Juni terjadi penurunan capaian. Jumlah unit kategori A menurun menjadi 3 unit dan kategori B menjadi 7 unit, sementara kategori D meningkat menjadi 8 unit dan kategori E kembali meningkat menjadi 5 unit. Penurunan ini mengindikasikan adanya penurunan konsistensi penerapan standar di beberapa unit. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kondisi tersebut antara lain tingginya beban pelayanan, pergantian atau rotasi petugas, ketidakpatuhan terhadap prosedur, kurang optimalnya supervisi, maupun belum maksimalnya tindak lanjut terhadap hasil monitoring sebelumnya.

Secara keseluruhan selama enam bulan pertama, kategori B (Baik) merupakan kategori yang paling dominan dengan total 52 penilaian, diikuti kategori C (Cukup) sebanyak 44 penilaian, kategori D (Kurang) sebanyak 25 penilaian, kategori A (Sangat Baik) sebanyak 23 penilaian, dan kategori E (Sangat Kurang) sebanyak 22 penilaian. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar unit telah berada pada kategori baik, namun masih terdapat sejumlah unit yang memerlukan pembinaan agar dapat mencapai kategori sangat baik.

Beberapa alasan petugas tidak menjalankan tugasnya karena merasa terbebani karena juga masih harus melakukan tindakan pelayanan di unit, ditambah dengan meningkatnya jumlah pasien rawat inap pada bulan ini. Disisi lain masih kurangnya kontrol / monitoring dari Karu terhadap evaluasi kinerja anggotanya sebagai PJ PPI.

Tindak lanjut:

- Lakukan pembinaan khusus bagi petugas dengan kategori kurang dan sangat kurang.
- Terapkan sistem mentoring (petugas dengan kategori baik mendampingi yang rendah).
- Evaluasi rasio petugas–pasien, terutama saat BOR tinggi.
- Pertimbangkan redistribusi tugas atau penambahan petugas pada jam sibuk.
- Sampaikan hasil evaluasi per unit dan per individu secara berkala.
- Berikan umpan balik langsung dan jelas terhadap temuan ketidakpatuhan.
- Beri apresiasi untuk petugas/unit dengan kategori baik–sangat baik.
- Terapkan teguran bertahap bagi yang tidak menunjukkan perbaikan.

II. PENGEMBANGAN PELAYANAN

No	Kegiatan Pokok	Progres Kegiatan
1	"PPI Quick Tips" (Program training singkat 1-2 menit yang diberikan setiap hari/setiap shift kepada staf (Perawat, nakes lain, CS, dll) focus pada 1 materi kecil terkait PPI.)	- Sudah dibuatkan instrument/rangkuman materi-materi terkait PPI yang bisa diakses oleh seluruh staf pada website PPI.  - Program sudah disosialisasikan melalui Karu unit. - Namun untuk dokumentasi pelaksanaannya masih dilakukan pengumpulan manual melalui WA, karena link pengumpulan belum dibuatkan.  - Pada bulan April saja yang rutin melakukan adalah unit : ICU/HCU, CS.  - Dari hasil dokumentasi, belum semua unit melaksanakan rutin program ini. Rutin: IRNA ICU-HCU, IRNA 5C Tidak Rutin: CS, IRNA 2/3/4A, IRNA 6/7/8A, Radiologi, Gizi, Laboratorium - Tindak lanjut: memberikan feedback pada unit dengan menyampaikan progress kegiatan dan unit mana saja yang rutin dan tidak rutin menjalankan program ini melalui WA grup supaya unit termotivasi untuk melakukan perbaikan dengan melaksanakan rutin.

III. KINERJA PRODUKTIVITAS

3.1 Hasil Surveilans HAIs dan Mutu PPI

Tabel 3.1 Hasil Capaian Surveilans PPI di RS Prima Husada Malang Tahun 2026

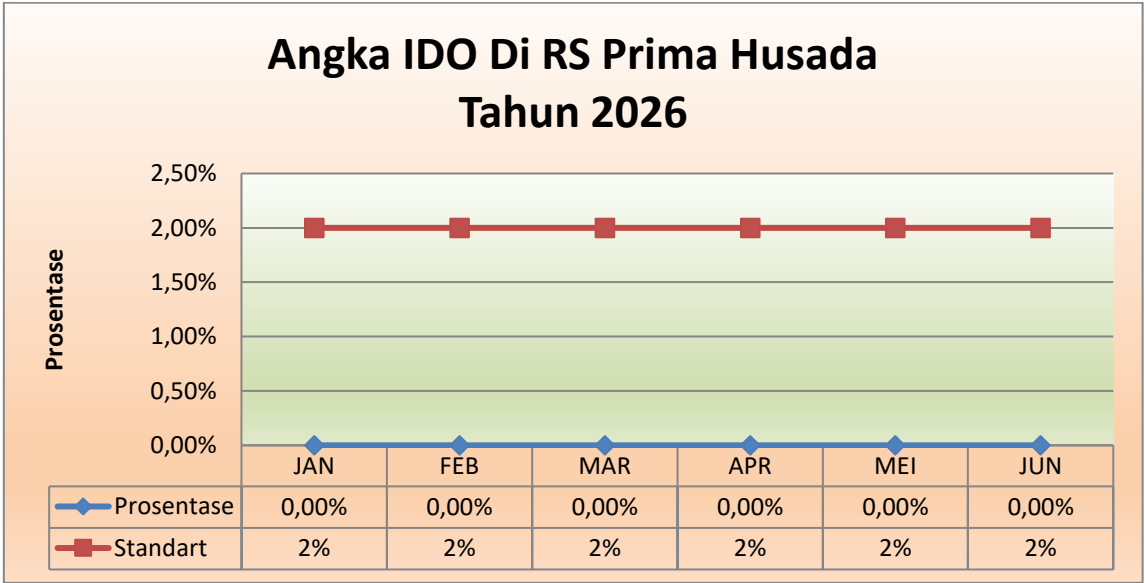
Jenis HAI's & Mutu PPI	Standart Nasional	Rate Infeksi % atau ‰ (Tahun 2026)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰						
VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰						
ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰						
Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,36%	0,3%	0,32%	0,33%	0,32%	0,07%						
Decubitus	0%	0%	0%	0%	0%	2,5%	0%						
Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,82%	85,87%	85,39%	85,93%	86,36%	86,82%						
Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	96,48%	96,88%	96,4%	96,48%	97,13%	97,22%						
Kejadian (paparan)	0	0	0	0	0	0	2						

3.1.1 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

Tabel 3.1.1 Data IDO berdasarkan jenis Tindakan operasi sesuai pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAIs Kemenkes)

Jenis Tindakan Operasi di RS	SSI (Juni 2026)		
	Jumlah Kasus	Jumlah Tindakan Operasi	Insiden (%)
Bedah Orthopedi	0	101	0%
Seksio Sesaria	0	74	0%
Apendiktomi	0	6	0%
Herniotomi	0	7	0%
Katarak	0	57	0%
CABG	-	-	-
Tumor Payudara	0	19	0%
Semua Operasi	0	454	0%

Gambar 3.1.1 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO) pada semua operasi di RS Prima Husada:



Analisa	Tidak terjadi kejadian IDO pada bulan ini pada keseluruhan jumlah operasi sebanyak 454 operasi.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi kejadian IDO.				
Permasalahan sebelumnya	• Tidak terjadi kejadian IDO.				
Tindakan yang dilakukan	• Pertahankan monitoring prosedur klinis dengan baik (monitoring perawatan luka pasien post operasi, kontrol proses pencukuran dan perawatan/desinfeksi alat cukur dan penggunaan pisau cukur disposable). • Melakukan monitoring kepatuhan aseptik di ruang-ruang perawatan. • Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk persiapan-proses dan pasca operasi.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Pertahankan bundle IDO berjalan dengan baik.	• Resiko IDO pada pasien berkurang/hilang.	• Pasien operasi	• Berkolaborasi dengan PPA terkait kondisi penyakit penyerta serta memberikan edukasi untuk mencegah agar risiko infeksi tidak menjadi aktual. • Memastikan bundle IDO (pre, durante, dan post op dilakukan dengan baik) • Melakukan monitoring persiapan pasien operasi khususnya pasien dianjurkan untuk mandi antiseptic/sabun untuk mengurangi risiko infeksi. • Penggunaan alat tetap diperhatikan proses sterilisasi central di CSSD terutama jika dilakukan operasi estafet dengan kasus yang sama (SC).	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/IPC�	• Satu bulan
• Pertahankan evaluasi pemahaman pemberian edukasi	• Meminimalisir kesalahpahaman penangkapan terkait edukasi perawatan pasien post operasi.	• Pasien post operasi.	• Koordinasi dengan perawat ruangan untuk memastikan pasien dan sudah mendapatkan edukasi terkait perawatan saat di rumah. • Pastikan pasien paham saat diedukasi dengan menanyakan kembali inti edukasi yang telah	• Perawat /Bidan • Karu • IPCLN/IPC�	• Satu bulan

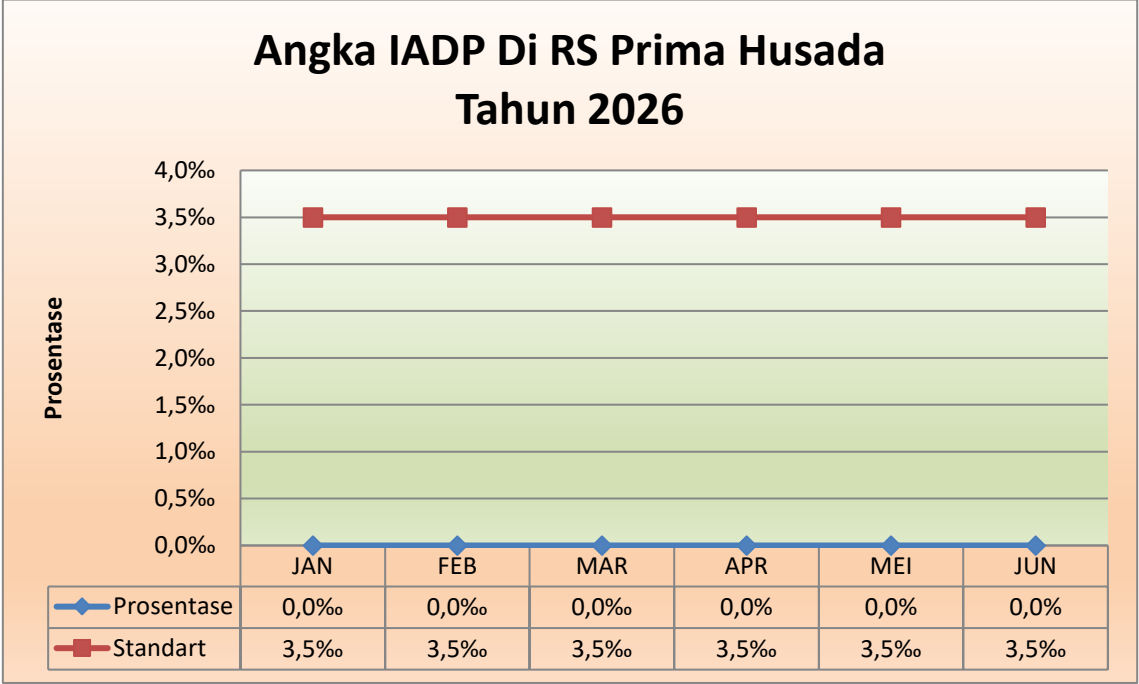
perawatan pasien pasca operasi			diberikan. (Memastikan komponen edukasi tersampaikan dengan baik/Komunikasikan-komunikasikan-pesan-media-feed back) • Berikan edukasi terutama terkait pemberian diit tinggi protein untuk membantu penyembuhan luka. • Lakukan edukasi pada saat pasien terdapat pendamping keluarga terutama yang satu rumah dengan pasien. • Berikan tambahan edukasi terkait kontrol pikiran pasien terutama terkait pantangan yang tidak perlu dipercaya di masyarakat.		
--------------------------------	--	--	--	--	--

3.1.2 IADP

Tabel 3.1.2 Data IADP berdasarkan ruang sesuai pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAIs Kemenkes)

Ruang	IADP (Juni 2026)		
	Jumlah Kasus	Jumlah lama hari pemakaian CVC	Insiden (‰)
ICU	0	0	0‰
HCU	0	0	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

Gambar 3.1.2 Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus IADP karena tidak ada tindakan pemasangan CVC.
Masalah saat ini	• Tidak terjadi IADP
Permasalahan sebelumnya	• Tidak terjadi IADP
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan tindakan pemasangan CVC. • Melakukan evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. • Melakukan monitoring kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. • Melakukan monitoring • perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.

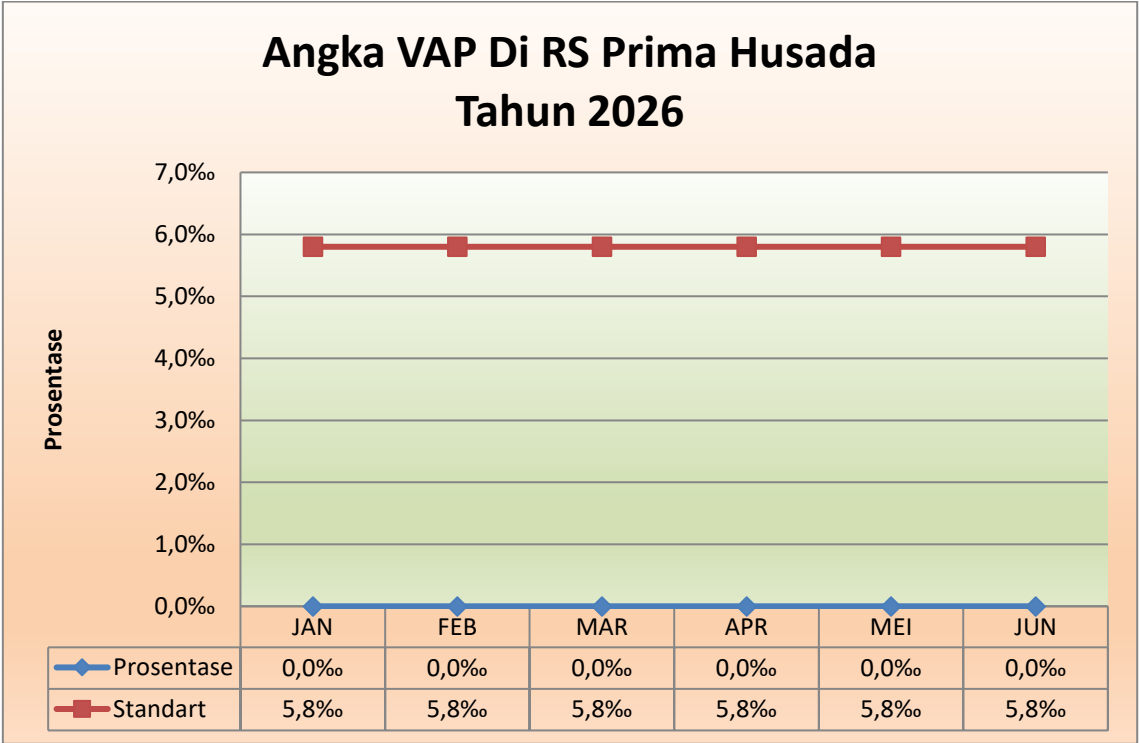
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle IADP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.	Pasien dengan pemakaian CVC.	- Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. - Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. - Monitoring evaluasi kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. - Monitoring evaluasi perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/PCN	Satu bulan

3.1.3 VAP

Tabel 3.1.3 Data VAP berdasarkan ruang sesuai pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Ruang	VAP (Juni 2026)		
	Jumlah Kasus	Jumlah lama hari pemakaian ventilator	Insiden (‰)
ICU	0	85	0‰
HCU	0	0	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

Grafik 3.1.3 Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 85 hari total lama pemasangan ventilator pada 15 pasien di ICU.
Masalah saat ini	Tidak terjadi VAP
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi VAP
Tindakan yang dilakukan	- Melakukan evaluasi perawatan pasien dengan terpasang ventilasi mekanik. - Melakukan audit monitoring saat pemasangan ventilator. - Melakukan observasi tanda-tanda dehidrasi (bibir kering) pada pasien yang terpasang ventilator. - Melakukan evaluasi saat pasien dilakukan penghisapan lendir / suction.

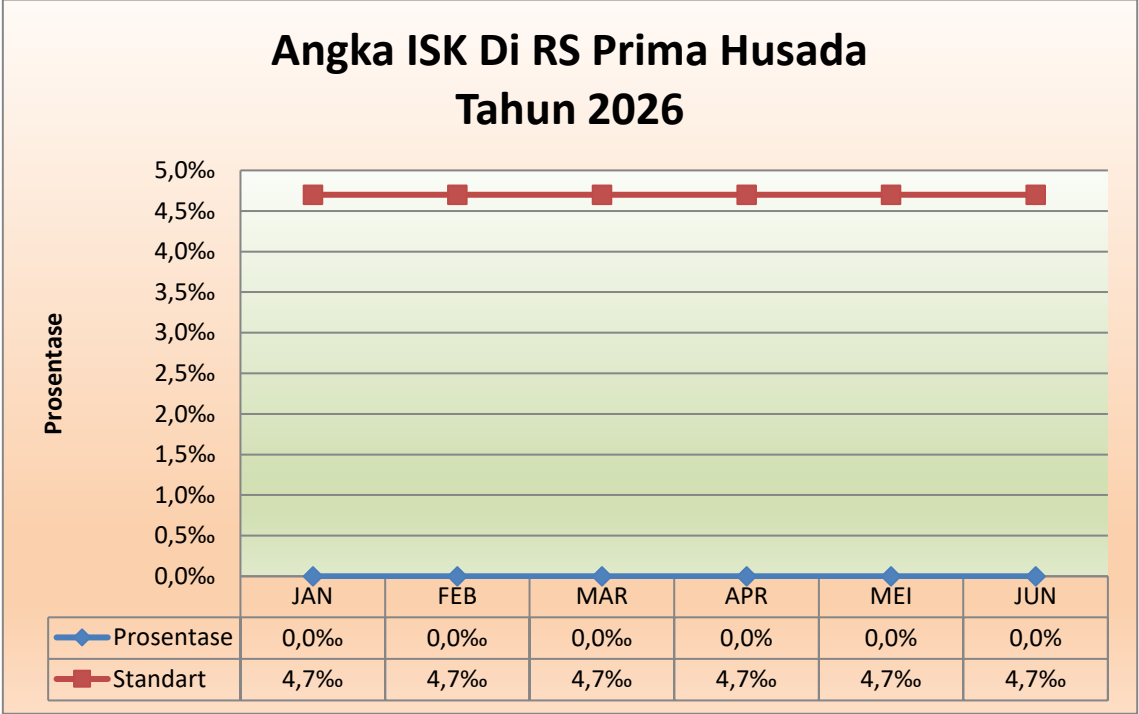
	Melakukan koordinasi dengan Kabid keperawatan terkait edaran kewajiban melakukan oral hygiene pada pasien yang terpasang ventilator dan mendokumentasikan di CPPT/Askep.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Tingkatkan kepatuhan bundle VAP, khususnya pelaksanaan oral hygiene.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP (oral hygiene).	Pasien yang terpasang ventilator mekanik	- Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. - Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. - Monitoring evaluasi posisi tepat pasien <i>head of bed</i> >30°-45°. - Monitoring evaluasi tindakan pemasangan ventilator. - Monitoring kegiatan oral hygiene dan pendokumentasian di RM. - Pemberian tindakan oral hygiene mewajibkan juga diedukasikan pada keluarga pasien, agar keluarga ikut aktif mengingatkan petugas untuk melakukan tindakan tersebut.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/PCN	Satu bulan

3.1.4 ISK

Tabel 3.1.4 Data ISK berdasarkan ruang sesuai pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Ruang	ISK (Juni 2026)		
	Jumlah Kasus	Jumlah lama hari pemakaian kateter	Insiden (‰)
ICU	0	206	0‰
HCU	0	59	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

Gambar 3.1.4 Grafik Angka Infeksi Saluran kencing (ISK)

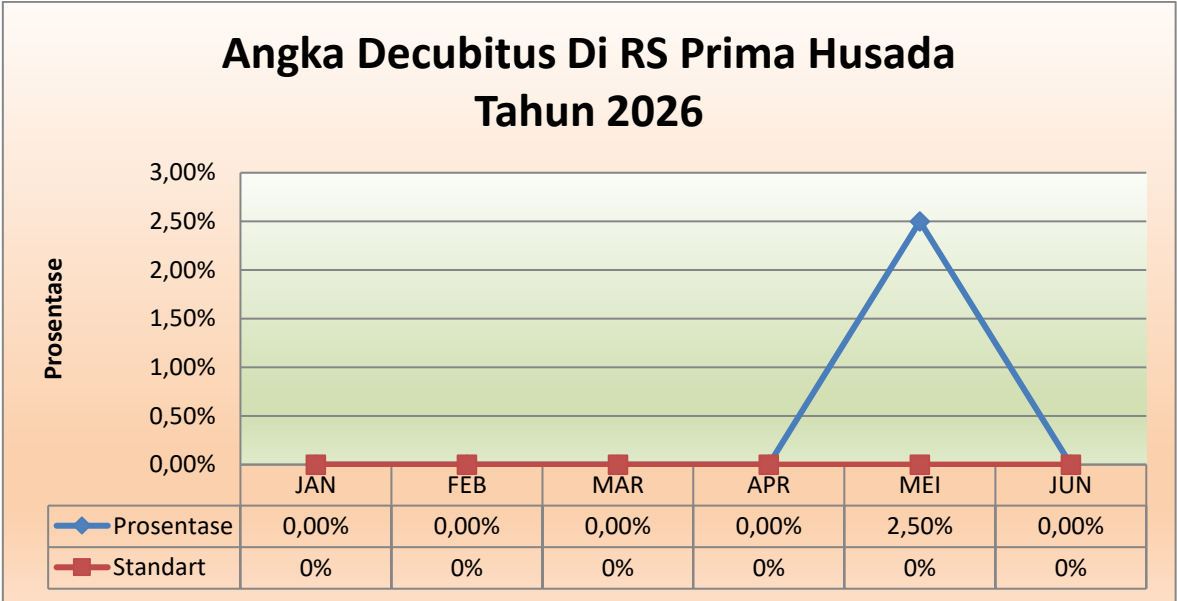


Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus ISK pada total 1450 hari lama pemakaian kateter pasien.
Masalah saat ini	Tidak terjadi ISK
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi ISK
Tindakan yang dilakukan	Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan perawatan pasien. Melakukan monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. Melakukan monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. Melakukan monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.

Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle ISK.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.	Pasien yang terpasang kateter	- Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. - Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. - Monitoring evaluasi teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. - Monitoring evaluasi perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/PCPN	Satu bulan

3.1.5 Decubitus

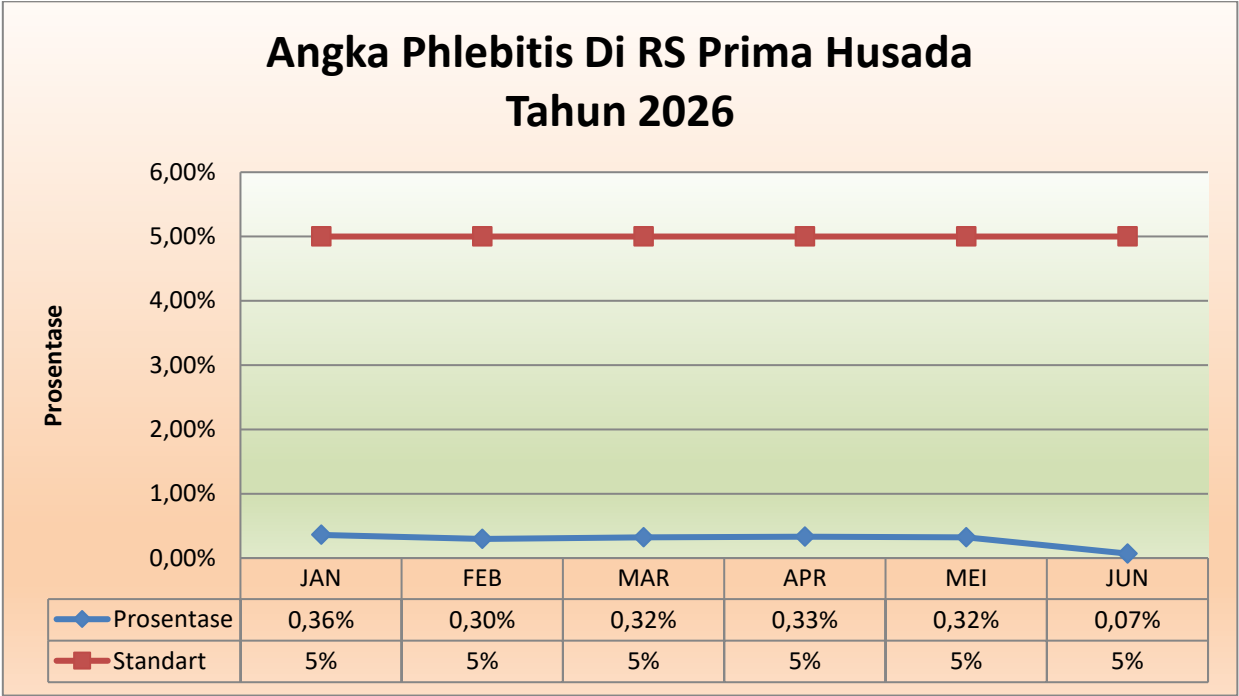
Gambar 3.1.5 Grafik Angka Decubitus



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus decubitus pada pada 30 pasien tirah baring lama.				
Masalah saat ini	• Tidak terjadi decubitus				
Permasalahan sebelumnya	• Tidak terjadi decubitus				
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan proses perawatan pasien. • Melakukan monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). • Melakukan monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. • Memastikan personal hygiene dilakukan dengan rutin oleh petugas.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Pertahankan kepatuhan pencegahan dekubitus.	• Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan pencegahan dekubitus.	• Pasien yang tirah baring lama (> 3x24 jam)	• Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. • Monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). • Anjurkan penggunaan kasur anti decubitus atau alternatif lain • Monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. • Lakukan perawatan luka rutin jika sudah terdapat luka supaya tidak melebar.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/IPCN	• Satu bulan

3.1.6 Phlebitis

Gambar 3.1.6 Grafik Angka Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)



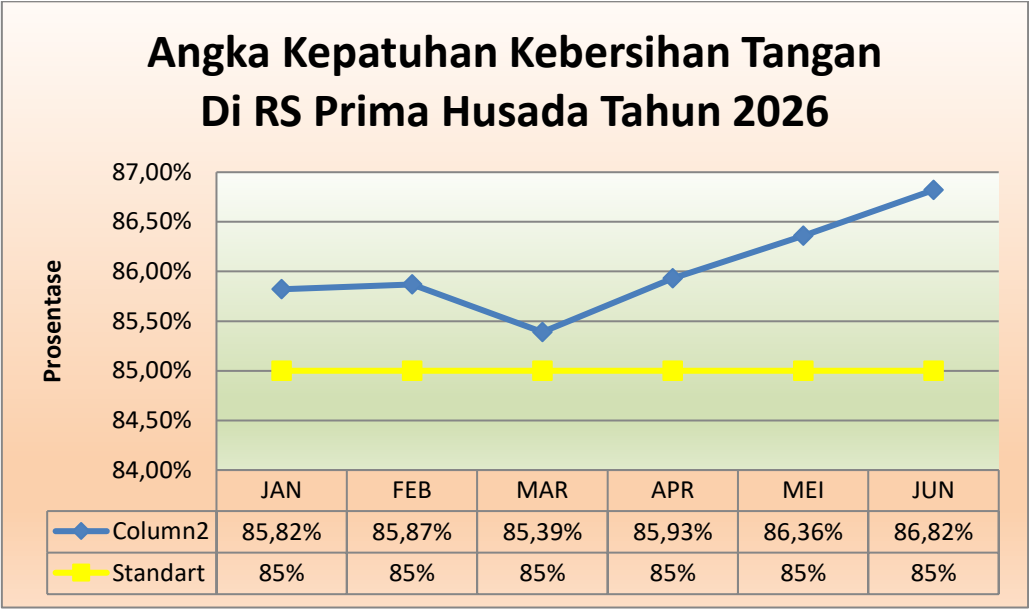
Analisa	Masih ditemukan kasus Phlebitis pada bulan ini dari total 2848 pasien yang terpasang infus setiap harinya dengan prosentase 0,07%, masih memenuhi standar nasional. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pasien pada bulan ini mengalami penurunan dan upaya pencegahan infeksi dan perawatan akses intravena pada bulan Mei berjalan optimal. Rendahnya angka phlebitis pada perawatan infus karena adanya pelaksanaan monitoring rutin lokasi insersi. Selain itu, efektivitas kolaborasi antara Komite PPI dan Komite Keperawatan, dengan adanya pembinaan serta monitoring berkala turut berkontribusi terhadap penurunan angka phlebitis selain itu karena terjadi penurunan jumlah pasien yang terjadi pada bulan ini sehingga itu juga berpengaruh pada hasil prosentasenya. Kondisi pada bulan ini menunjukkan bahwa tindakan korektif dan penguatan kepatuhan yang telah dilakukan memberikan hasil positif. Dari data yang diperoleh terdapat 2 pasien yang mengalami phlebitis. Faktor penyebab kemungkinan besar: Obat pekat/iritatif/antibiotik, pemberian transfusi darah.
---------	--

	Dari 13 pasien yang ditanyai, tidak ditemukan pasien yang rawat inap mengalami infus slong (cairan infus pada indikator selang infus habis).				
Masalah saat ini	• Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, termasuk juga pemberian transfusi darah. • Faktor internal pasien seperti usia pasien yang beresiko phlebitis juga berpengaruh, perlunya edukasi lanjut terkait ini.				
Permasalahan sebelumnya	• Pengenceran obat kurang optimal dan kurang terkontrol di ruangan. • Teknik pemasangan infus yang tidak seragam, serta perawatan yang kurang optimal.				
Tindakan yang dilakukan	• Mengkoordinasikan dengan komite keperawatan terkait sosialisasi pemasangan infus yang benar dan penanganan phlebitis. • Memberikan edukasi pada pasien setelah pemasangan infus terutama pada pasien yang beresiko tinggi phlebitis karena faktor internal. • Menganjurkan perawat untuk melakukan monitoring luka tusukan infus terutama pada pasien yang terpasang cairan pekat setiap hari setelah melakukan injeksi. • Menyarankan petugas untuk memberikan kompres hangat pada pasien yang mendapatkan cairan pekat pada area tangan yang terpasang infus untuk merilekskan pembuluh darah dan cairan pekat/darah tidak gampang menggumpal. • Menganjurkan perawat untuk terus mengingatkan edukasi tambahan terkait perawatan saat terpasang infus.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Perbaiki kepatuhan bundle phlebitis.	• Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	• Pasien yang terpasang infus	• Monitoring penyuntikan yang aman benar dilakukan. • Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic diberikan secara aman. • Monitoring kondisi luka tusukan infus setiap selesai melakukan injeksi. • Memberikan injeksi obat secara perlahan untuk mengurangi nyeri dan memperkecil resiko phlebitis. • Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan. • Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus dan kebersihan tangan sebelum memakai sarung tangan. • Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/IPCN	• Satu bulan

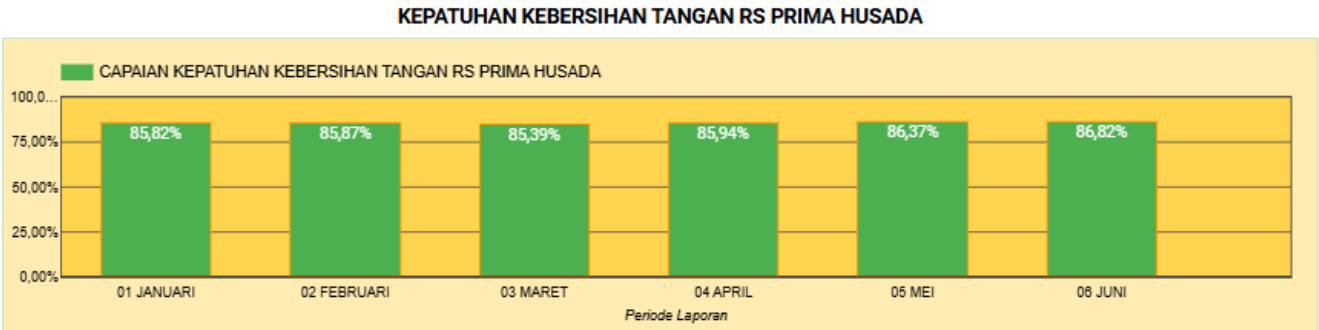
			• Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat.		
• Pengendalian Penggunaan Obat Iritatif.	• Mengurangi resiko phlebitis karena pemberian obat pekat/iritan.	• Perawat/bidan • Apoteker	• Mewajibkan pengenceran adekuat sesuai standar farmasi. • Laju infus dikontrol untuk antibiotik dan obat pekat. • Koordinasi dengan Instalasi Farmasi untuk memberikan label “Obat Iritatif – Perlu Pengenceran”.	• Perawat /Bidan • Apoteker • Karu • IPCLN/PCPN	• Satu bulan
• Perbaikan Proses Pemasangan & Perawatan Infus	• Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	• Perawat/bidan	• Re-education SOP pemasangan infus (vena besar, hindari area fleksi). • Pelatihan ulang teknik aseptik untuk perawat IGD dan IRNA 8A. • Audit kepatuhan perawatan VAP & manajemen infus setiap bulan. • Checklist harian pemeriksaan lokasi infus oleh perawat jaga.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/PCPN	• Tiga bulan

3.1.7 Kebersihan Tangan

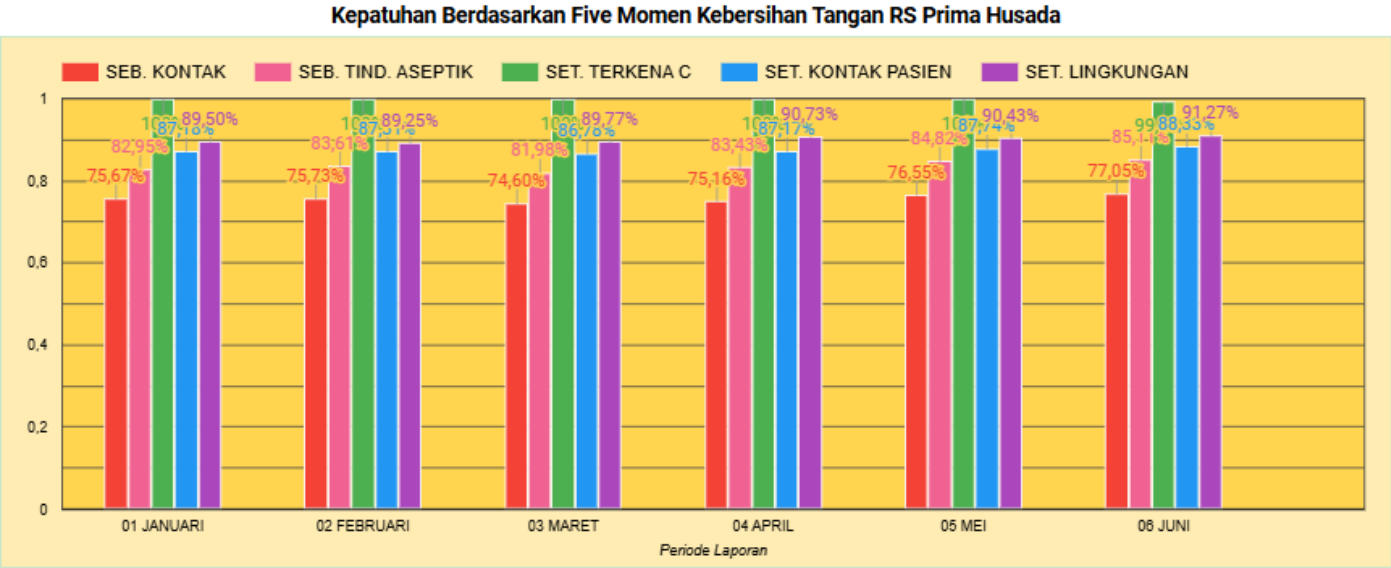
Gambar 3.1.7 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (Hand Hygiene)



Gambar 3.1.7.1 Grafik Kepatuhan 6 Langkah Kebersihan Tangan (Hand Hygiene)



Gambar 3.1.7.2 Grafik Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan 5 Momen Cuci Tangan

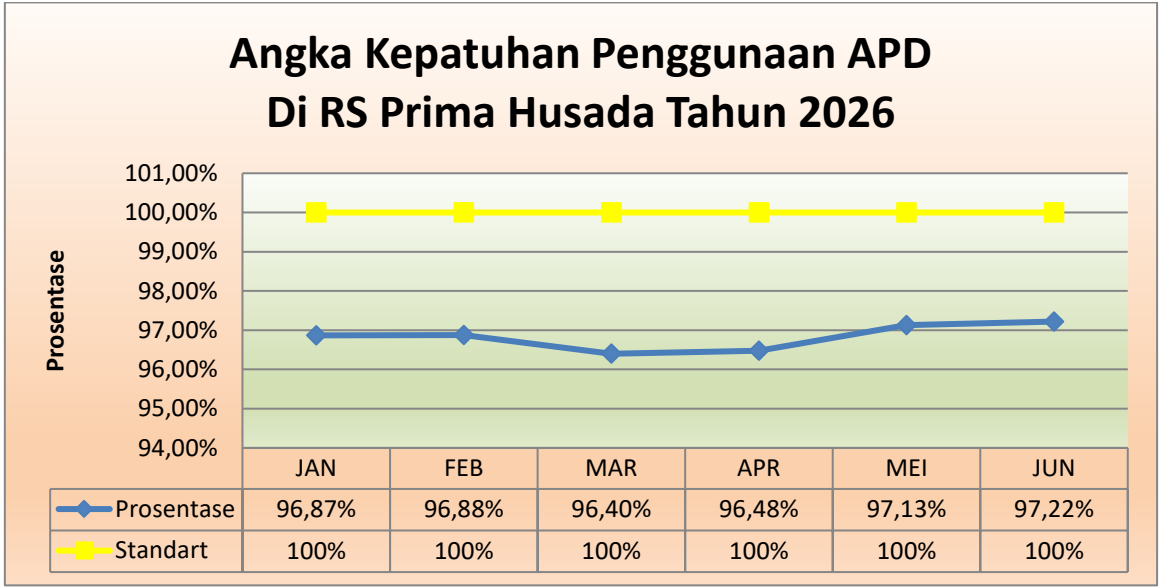


Analisa	Nilai kepatuhan hand hygiene bulan Juni 2026 berada sedikit di atas standar (selisih 0,46%). Meskipun masih memenuhi standar, terjadi sedikit peningkatan kepatuhan, yang berarti ada sedikit peningkatan kedisiplinan atau konsistensi dalam penerapan cuci tangan. Tren ini mengindikasikan perlunya penguatan pengawasan dan motivasi ulang kepada tenaga kesehatan agar tingkat kepatuhan terus meningkat. Nilai kepatuhan terhadap 6 langkah cuci tangan pada bulan ini: 86,82%. Nilai ini lebih tinggi sedikit dibanding bulan sebelumnya (Mei 2026: 86,36%). Artinya, meskipun tenaga kesehatan mencuci tangan, kemungkinan masih belum melakukan seluruh 6 langkah dengan benar. Peningkatan sedikit ini bisa mencerminkan peningkatan perhatian terhadap teknik yang benar dan penurunan proses audit cuci tangan karena kebanyakan dari staf akan melakukan sesuai standar saat diamati, seharusnya sudah menjadi kebiasaan untuk budaya cuci tangan dengan 5 momen dan 6 langkah yang tepat, bukan hanya frekuensi mencuci tangan saja. Pelaksanaan 5 momen cuci tangan di bulan ini sudah cukup baik, namun perlu fokus peningkatan pada momen sebelum kontak pasien melalui edukasi dan reminder visual di area perawatan. Selain itu dengan adanya program "PPI Quick Tips" diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan staf di unit.
Masalah saat ini	• Kedisiplinan dan kesinambungan praktik belum merata. • Teknik 6 langkah cuci tangan belum dilakukan secara sempurna.

	• Kepatuhan muncul karena pengawasan (observer effect). • Edukasi dan reminder visual belum optimal.				
Permasalahan sebelumnya	• Ketidakonsistenan dalam melakukan 5 momen cuci tangan. • Teknik 6 langkah cuci tangan belum dilakukan secara sempurna. • Kepatuhan muncul karena pengawasan (observer effect). • Edukasi dan reminder visual belum optimal. • Kedisiplinan dan kesinambungan praktik belum merata.				
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. • Memberikan contoh cara cuci tangan yang benar saat mengisi diklat KE. • Melakukan kontrol monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. • Mengajarkan cuci tangan yang benar saat melakukan audit di ruangan. • Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Meningkatkan kebersihan tangan.	• Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	• Seluruh petugas pelayanan pasien	• Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. • Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. • Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. • Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. • Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik. • Lakukan sosialisasi ke petugas langsung pada saat melakukan supervisi untuk mengingatkan kebiasaan petugas dalam kebersihan tangan.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/PCN	• Satu bulan

• Lanjutkan audit kepatuhan secara acak dan supervisi pengamatan rutin.	• Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	• Petugas kesehatan	• Melakukan audit mendadak (spot check) agar kebiasaan cuci tangan terpantau tanpa pengaruh pengawasan langsung. • Kepala ruangan dan IPCN melakukan pemantauan harian terutama pada shift pagi & sore. • Memberikan feedback cepat ketika ditemukan ketidaksesuaian.	• Karu • IPCLN/IPCN	• Satu bulan
---	---	---	---	---	--

3.1.8 Kepatuhan APD
Gambar 3.1.8 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas

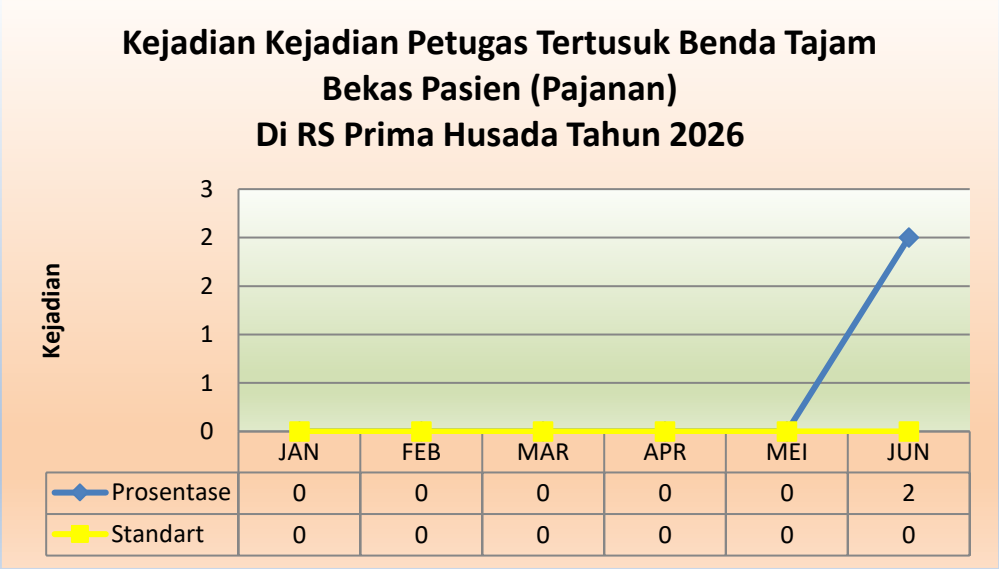


Analisa	Kepatuhan penggunaan APD masih berada di bawah standar 100%, dengan hasil pada bulan ini 97,22%. Artinya, meskipun staf menggunakan APD, masih terdapat petugas yang tidak tepat atau tidak sesuai indikasi pemakaian APD. Terjadi peningkatan sedikit pada bulan ini, menunjukkan adanya: peningkatan perilaku penggunaan APD, meningkatnya kesadaran staf, atau bertambahnya pengaruh dari
---------	--

	pengawasan dan edukasi langsung yang dilakukan bulan sebelumnya. Nilai tetap belum mencapai standar 100%, sehingga masih ada: ketidakpatuhan dalam penggunaan APD lengkap dan juga pemakaian APD yang berlebihan sehingga dianggap tetap tidak patuh. Perubahan perilaku belum konsisten penggunaan APD masih dipengaruhi faktor situasional, bukan kebiasaan yang terbentuk secara kuat.				
Masalah saat ini	• Masih ada salah persepsi “tindakan ringan tidak perlu APD lengkap atau lupa tidak melepas APD”. • Audit belum merata.				
Permasalahan sebelumnya	• Ketidakkonsistenan penggunaan APD antar shift dan antar unit. • Masih ada salah persepsi “tindakan ringan tidak perlu APD lengkap atau lupa tidak melepas APD”. • Audit belum merata.				
Tindakan yang dilakukan	• Mengingatkan kembali petugas yang memakai APD berlebihan terkait transmisi penyebaran penyakitnya. • Melakukan evaluasi penggunaan stok APD pada petugas koordinasi dengan pengadaan farmasi. • Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD, konfirmasi Karu dan SDM). • Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. • Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. • Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. • Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	• Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	• Seluruh petugas pelayanan pasien	• Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. • Penguatan budaya keselamatan dengan melakukan briefing harian dengan pesan wajib: “APD lengkap sebelum kontak dengan pasien atau cairan tubuh.” • Tingkatkan sosialisasi pada petugas langsung saat melakukan supervisi unit. • Koordinasi dengan IPCD untuk membantu meningkatkan pemahaman terkait APD pada para DPJP. • Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan.	• Seluruh petugas pelayanan di RS.	• Satu bulan

			• Berkolaborasi dengan SDM terkait ketidak disiplin petugas dalam pemakaian APD. • Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. • Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. • Audit kepatuhan harian per shift, IPCN/kepala ruangan/IPCLN/PJ Shift melakukan audit: pagi, sore, malam, minimal 3–5 observasi per shift. Catat petugas dengan angka kepatuhan rendah untuk ditindaklanjuti pada evaluasi kinerja.		
--	--	--	---	--	--

3.1.9 Kejadian Petugas tertusuk benda Tajam
Gambar 3.1.10 Garfik Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan).

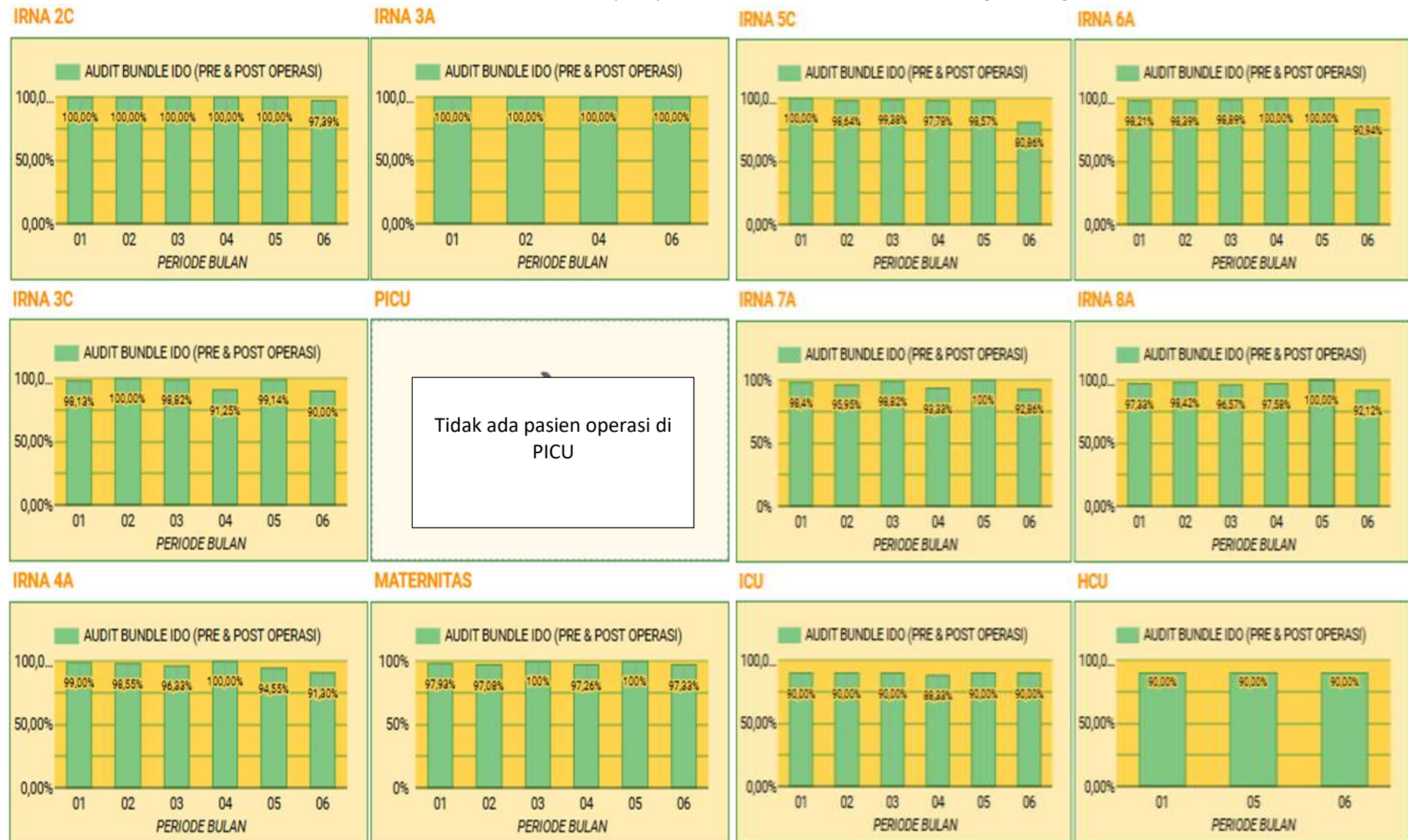


Analisa	Pada bulan Juni ini ditemukan 2 kejadian tertusuk jarum bekas pasien pada petugas kebersihan dan perawat IGD.				
Masalah saat ini	Ditemukan 2 kejadian pajanan tertusuk benda tajam pada bulan ini.				
Permasalahan sebelumnya	Tidak ditemukan kejadian pajanan tertusuk benda tajam pada bulan lalu.				
Tindakan yang dilakukan	- Mengingatkan untuk melakukan penyuntikan yang aman dan pengolahan benda tajam yang baik dan benar. - Menganjurkan untuk tidak memegang area badan safety box, untuk menghindari jika ada jarum yang tembus, disarankan memegang tali safety box saja. - Menyarankan membawa safety box atau wadah khusus untuk langsung membuang jarum/benda tajam setelah tindakan. - Melakukan pemilahan sampah yang benar, terutama benda tajam. - Menggunakan APD yang sesuai untuk meminimalisir resiko pajanan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan proses penyuntikan yang aman dan pengelolaan benda tajam yang baik.	Menurunkan kejadian pajanan sesuai dengan standar 0 kejadian.	Seluruh petugas pelayanan pasien	- Monitoring proses pemilahan sampah khususnya benda tajam saat melakukan tindakan. - Monitoring penggunaan safety box pada troli tindakan. - Biasakan petugas untuk membersihkan peralatan yang digunakan langsung tanpa mengoperkan pada shift berikutnya. - Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan untuk mencegah paparan. - Monitoring teknik recapping tutup jarum.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

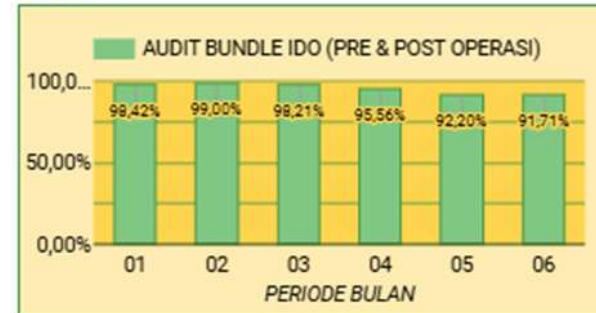
3.2 Hasil Audit Bundle HAI's

3.2.1 Audit Bundle IDO

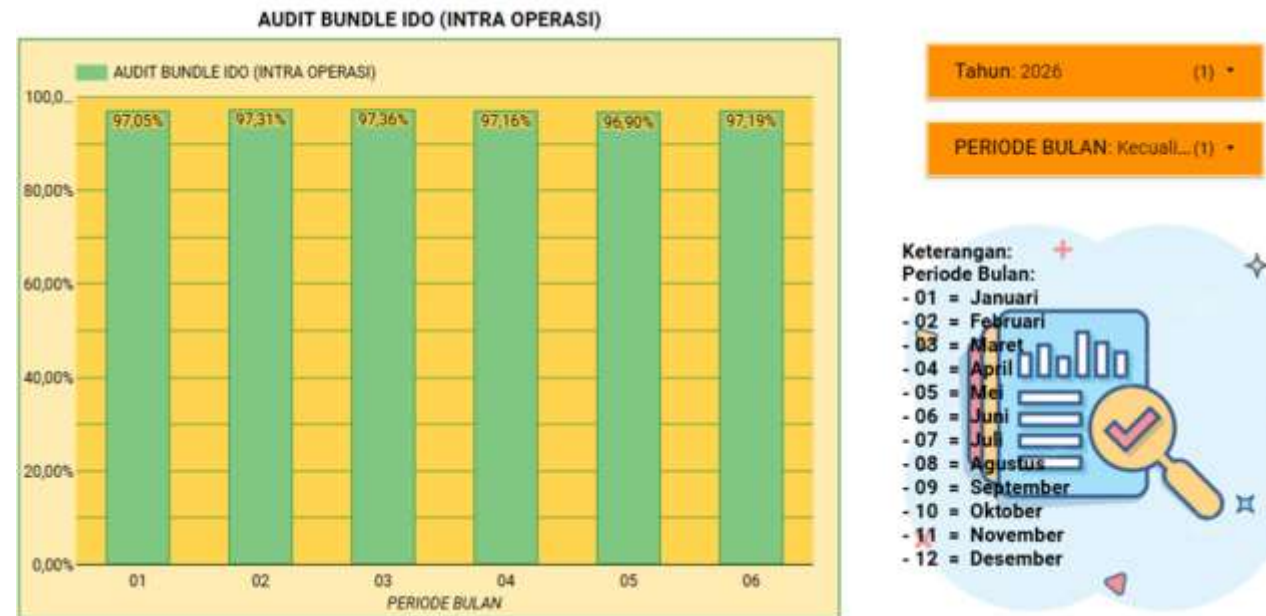
a. Gambar 3.2.1 Grafik Hasil Audit Bundle Infeksi Daerah Operasi (IDO) Pre dan Post Operasi dari masing-masing unit:



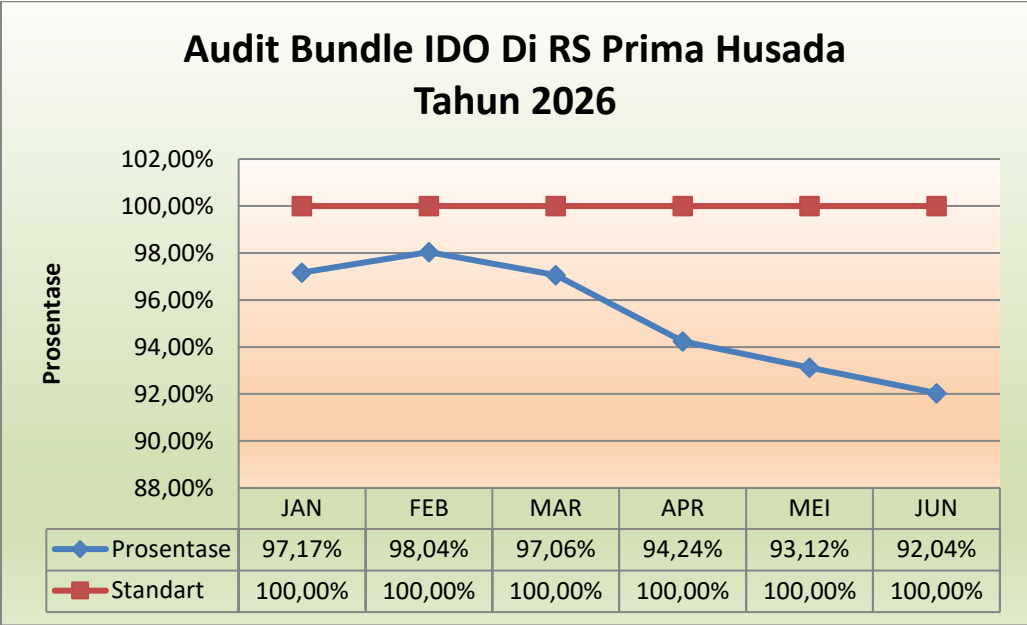
IRNA 2A



b. Gambar 3.2.1.1 Grafik Hasil Audit Bundle Infeksi Daerah Operasi (IDO) Intra Operasi di IKO:



c. Gambar 3.2.1.2 Grafik Rata-rata Hasil Audit Bundle Infeksi Daerah Operasi (IDO):

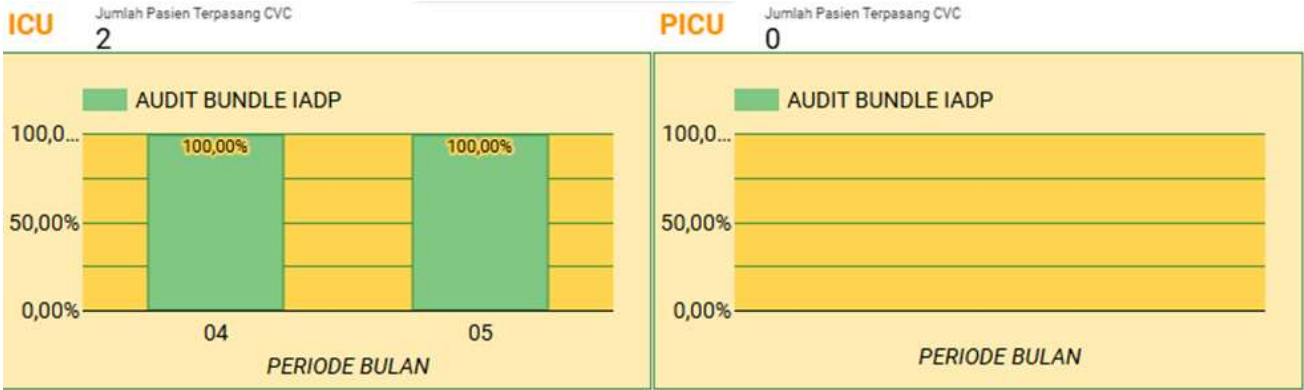


Kegiatan Pokok	Audit bundle IDO				
Rincian Kegiatan	- Melakukan audit di setiap ruangan - Menganalisa hasil audit - Melakukan tindak lanjut hasil audit				
Hasil Analisa	Hasil audit bundle IDO pada bulan ini secara keseluruhan yaitu 92,04%. Dimana pada bulan ini audit bundle IDO pre operasi mengalami penurunan yang signifikan pada anjuran pasien untuk mandi antiseptic/sabun sebelum dilakukan operasi namun belum bisa terlaksana dilapangan dikarenakan kebanyakan pasien tidak diberi edukasi atau dianjurkan untuk mandi menggunakan cairan aseptic/sabun, selain itu pasien dengan post KLL atau terdapat luka terbuka takut lukanya perih terkena air meskipun sudah dianjurkan untuk diseka saja atau pada pasien yang dilakukan operasi cyto. Tetapi pada kondisi pasien yang operasi loadingan dari awal perencanaan operasi sudah diberikan edukasi untuk mandi sebelum proses operasi berlangsung. Untuk pasien yang operasi cyto yang tidak sempat dilakukan mandi/seka namun sudah rutin selalu dilakukan desinfeksi area sekitar luka.				
RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Penerapan bundle IDO.	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam	Kepatuhan audit bundle IDO petugas	Menganjurkan petugas pre operasi untuk tetap melakukan mandi antiseptic / air sabun dengan cara diseka jika pasien dalam kondisi urgent.	- Perawat /Bidan - Dokter	Satu bulan

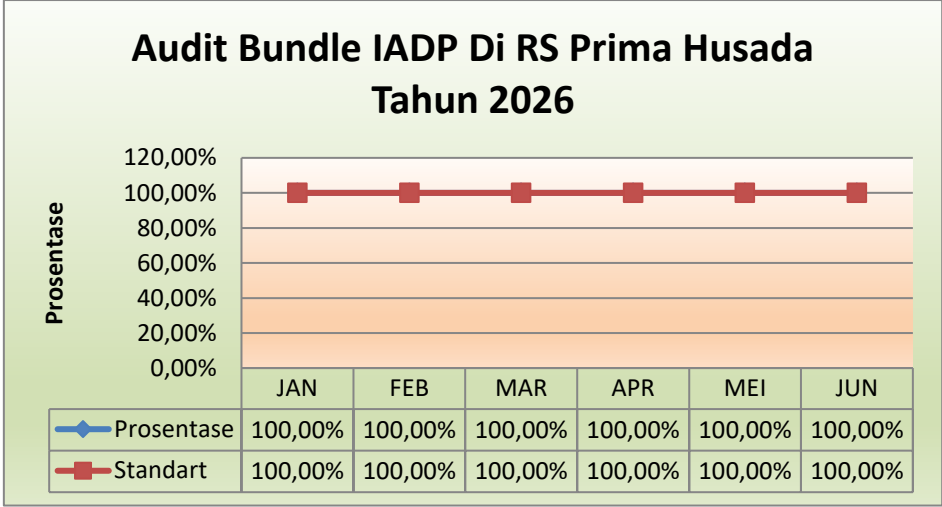
	menjalankan bundle IDO.		• Menyarankan untuk tim yang sudah selesai melakukan tindakan pada pasien untuk menjauhi meja operasi untuk meminimalkan resiko infeksi. • Mengingatkan kembali pemakaian sarung tangan steril pada saat melakukan tindakan rawat luka. • Monitoring pembersihan alat dan ruangan IKO harus dijalankan dan ditingkatkan. • Koordinasi dengan perawat ruang bedah untuk mengingatkan prinsip steril terutama pada tim operasi untuk tetap dijalankan. • Monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas terutama pada saat akan melakukan tindakan rawat luka pasien.	• Karu • IPCLN/PCN.	
--	-------------------------	--	---	--	--

3.2.2 Audit Bundle IADP

Gambar 3.2.2 Grafik Hasil Audit Bundle Infeksi Aliran Darah Primer (IADP) masing-masing unit:



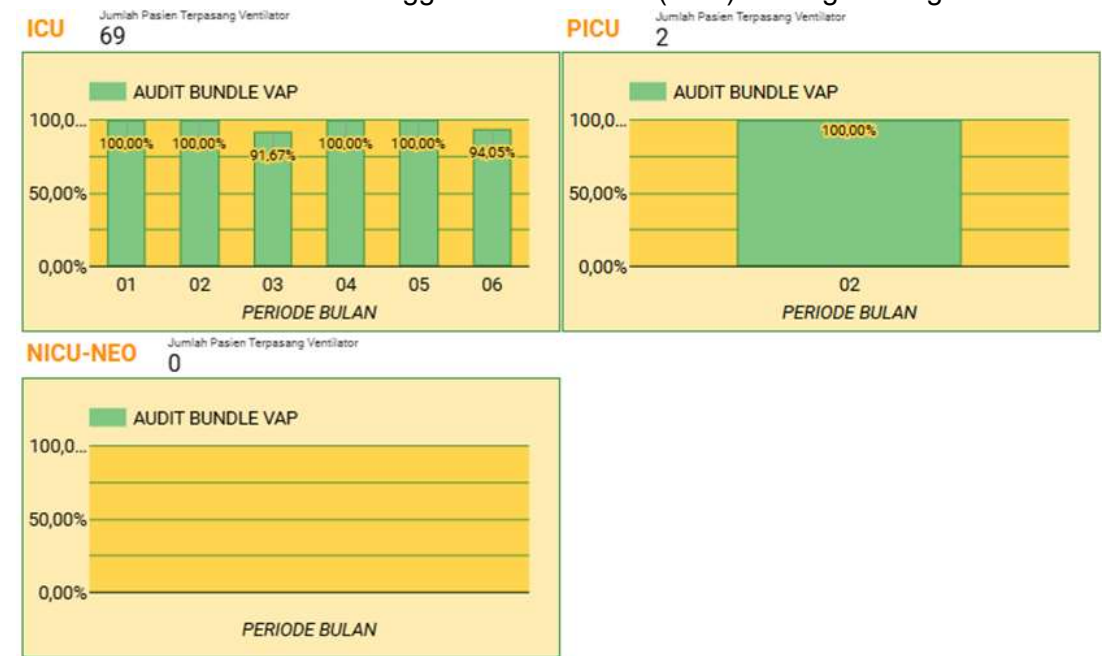
Gambar 3.2.2.1 Grafik Hasil Audit Bundle Infeksi Aliran Darah Primer (IADP):



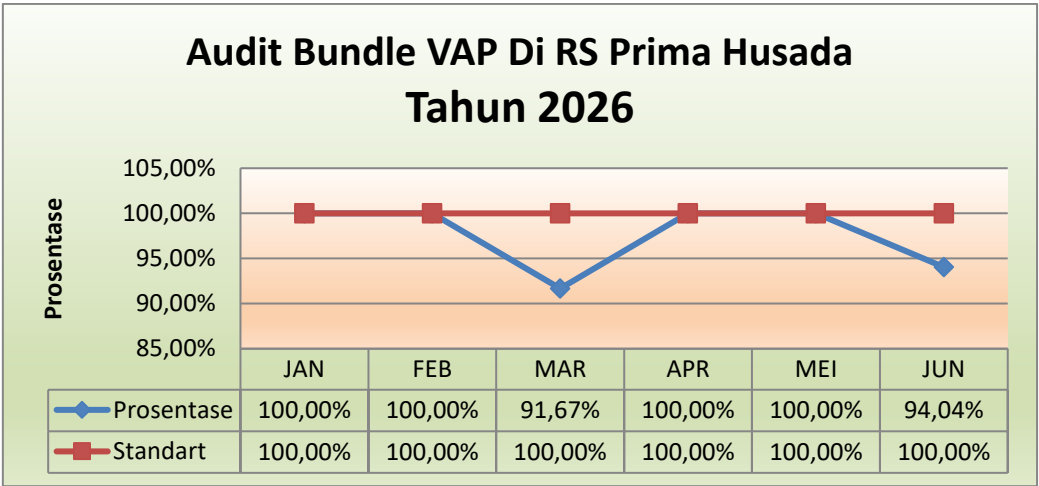
Kegiatan Pokok	Audit bundle IADP				
Rincian Kegiatan	- Melakukan audit di setiap ruangan - Menganalisa hasil audit - Melakukan tindak lanjut hasil audit				
Hasil Analisa	Hasil audit bundle IADP pada bulan ini yaitu 100%, karena tidak ada pemasangan CVC pada pasien.				
RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Tingkatkan kepatuhan bundle IADP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.	Kepatuhan bundle IADP tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	- Monitoring kepatuhan 5 moment cuci tangan. - Monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. - Monitoring kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. - Monitoring perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPC�	Satu bulan

3.2.3 Audit Bundle VAP

Gambar 3.2.3 Grafik Hasil Audit Bundle Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP) masing-masing unit:



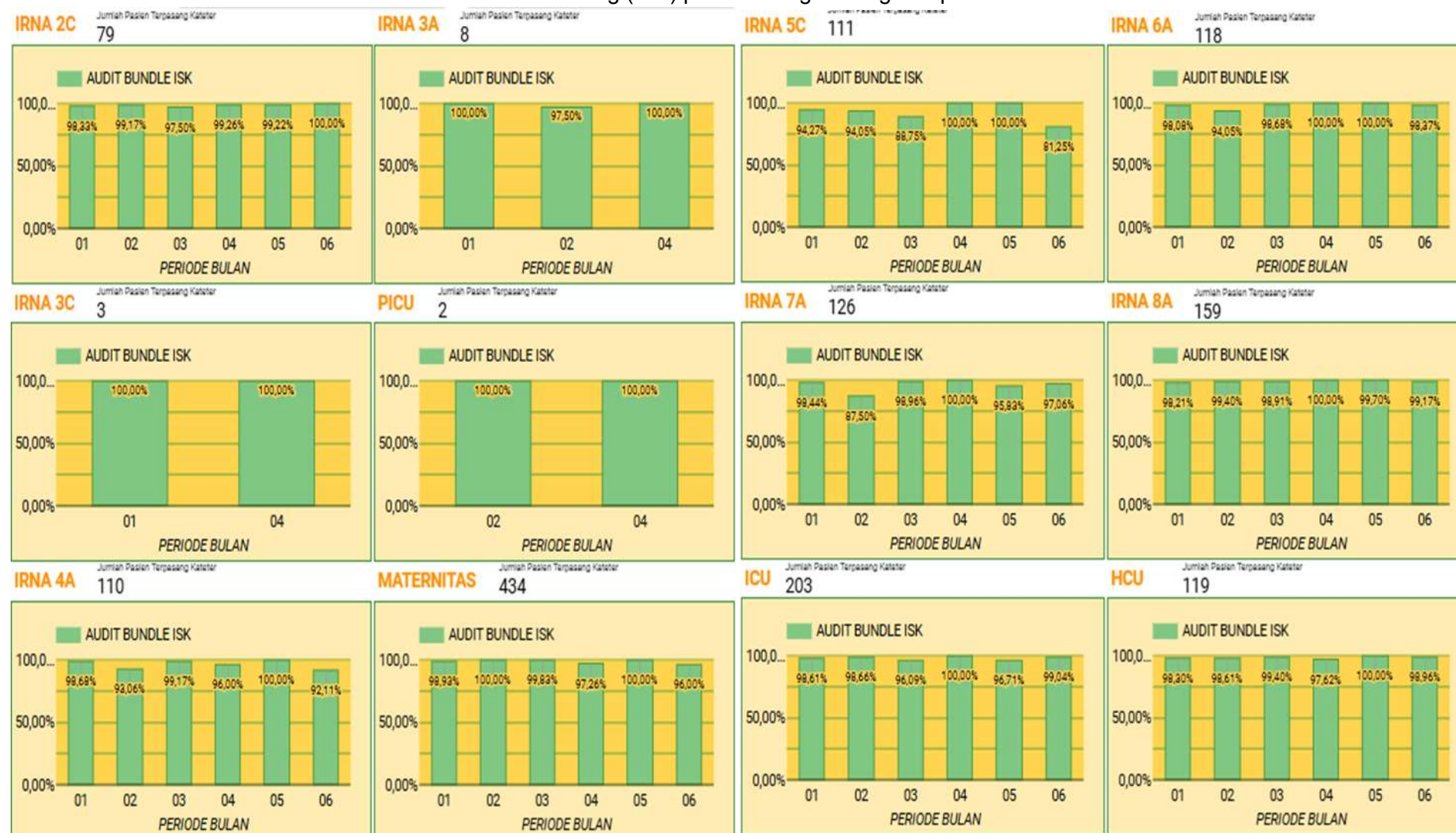
Gambar 3.2.3.1 Grafik Hasil Audit Bundle Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP):



Kegiatan Pokok	Audit bundle VAP				
Rincian Kegiatan	- Melakukan audit di setiap ruangan - Menganalisa hasil audit - Melakukan tindak lanjut hasil audit				
Hasil Analisa	Hasil audit bundle VAP pada bulan ini yaitu 94,04%, dimana pada bulan ini terdapat total hanya 85 jumlah hari lama pemasangan ventilator mekanik di unit ICU pada 15 orang pasien, petugas melakukan bundle VAP terjadi penurunan dikarenakan jumlah lama pemasangan terjadi penurunan, selain itu bundle VAP yang agak susah dijalankan yaitu oral hygiene secara rutin setiap 4jam.				
RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle VAP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP.	Kepatuhan bundle VAP tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	- Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. - Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. - Monitoring evaluasi posisi tepat pasien <i>head of bed</i> >30°-45°. - Monitoring evaluasi tindakan pemasangan ventilator. - Koordinasi dengan kabid keperawatan untuk mewajibkan & menertibkan oral hygiene setiap 4 jam sekali pada seluruh pasien yang terpasang ventilator mekanik dan mendokumentasikan pada Askep atau CPPT. - Pemberian tindakan oral hygiene mewajibkan juga diedukasikan pada keluarga pasien, agar keluarga ikut aktif mengingatkan petugas untuk melakukan tindakan tersebut.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPCN	Satu bulan

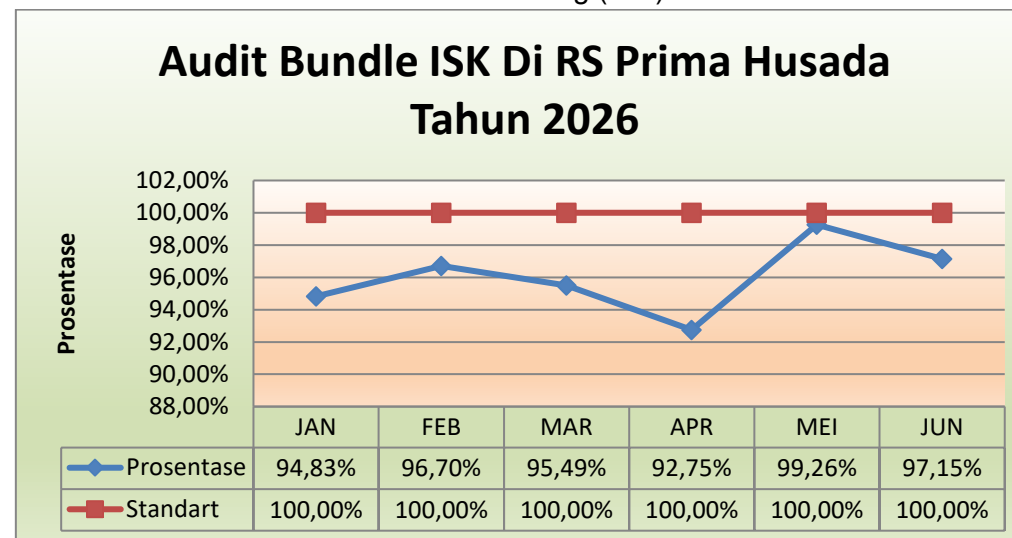
3.2.4 Audit Bundle ISK

Gambar 3.2.4 Grafik Hasil Audit Bundle Infeksi Saluran kencing (ISK) pada masing-masing unit perawatan:





Gambar 3.2.4.1 Grafik Rata-rata Hasil Audit Bundle Infeksi Saluran kencing (ISK):



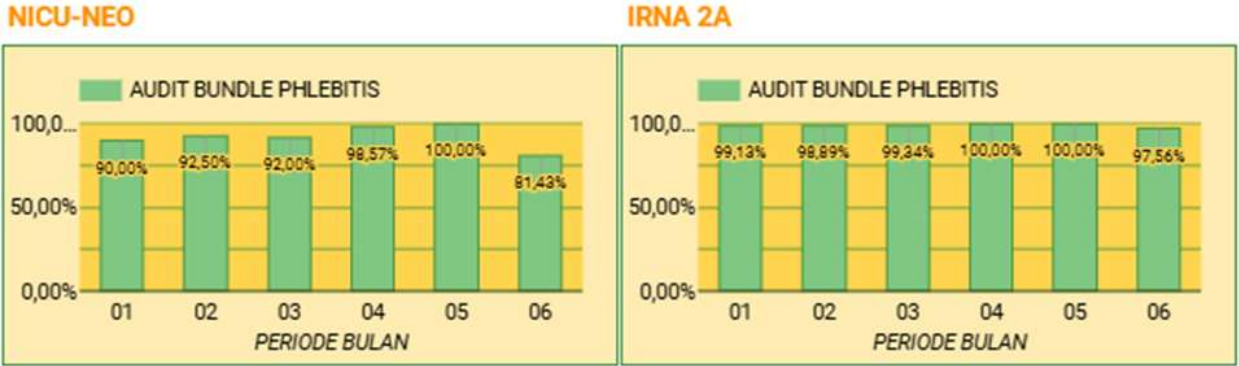
Kegiatan Pokok	Audit bundle ISK
Rincian Kegiatan	- Melakukan audit di setiap ruangan - Menganalisa hasil audit - Melakukan tindak lanjut hasil audit

Hasil Analisa	Hasil audit bundle ISK pada bulan ini yaitu 97,15%, dimana pada bulan ini terdapat pemasangan kateter di unit perawatan pasien dengan total jumlah lama hari pemasangan kateter yaitu 1450 hari (dari hasil surveilans). Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan sedikit pada prosentase audit bundle isk dibandingkan dengan bulan lalu (Mei : 99,26%). Hal ini disebabkan terjadinya penurunan dilakukannya cuci tangan sebelum tindakan lalu petugas memakai sarung tangan baru saat akan melakukan tindakan insersi. Teknik aseptik sudah sangat dijaga dengan meletakkan bagian steril pada troli tindakan agar meminimalisir kontaminasi dengan bed/anggota badan pasien. Pemakaian fiksasi plester terkadang tidak langsung dilakukan terutama diunit, padahal di IGD sudah rutin dilakukan, terkadang kurangnya juga jumlah ml water for injection untuk pengunci di kateternya. Untuk penggunaan kantong urin sudah menggunakan drainase sistem tertutup, peletakan kantong urin harus menggantung di bawah kantong kemih juga dilakukan serta untuk wadah pembuangan urin dianjurkan beda setiap pasiennya.				
RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle ISK.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.	Kepatuhan bundle ISK tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	- Monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine. - Monitoring kepatuhan 5 moment cuci tangan. - Monitoring kepatuhan pemakaian APD. - Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPCN	Satu bulan

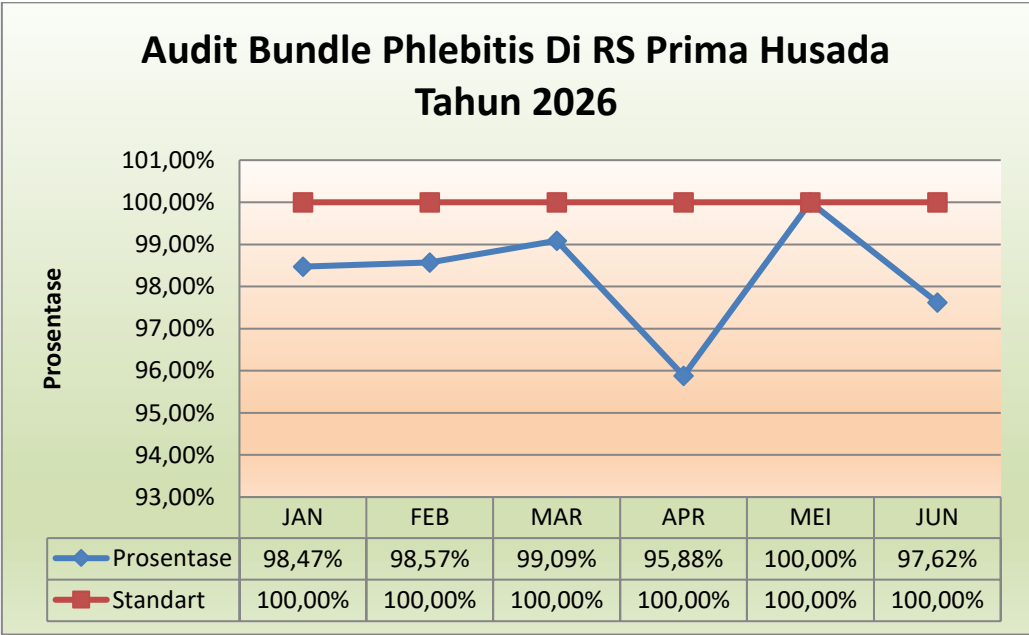
3.2.5 Audit Bundle Phlebitis

Gambar 3.2.5 Grafik Hasil Audit Bundle Infeksi Jarum Infus (Phlebitis) pada masing-masing unit:





Gambar 3.2.5.1 Grafik Rata-rata Hasil Audit Bundle Infeksi Jarum Infus (Phlebitis):



Kegiatan Pokok	Audit bundle Phlebitis				
Rincian Kegiatan	- Melakukan audit di setiap ruangan - Menganalisa hasil audit - Melakukan tindak lanjut hasil audit				
Hasil Analisa	Hasil audit bundle phlebitis pada bulan ini yaitu 97,62%, dimana pada bulan ini adanya penurunan drastis pada kepatuhan hand hygiene saat hendak memasang infus, teknik aseptik rutin tidak diterapkan pada saat akan melakukan penyuntikan pada selang infus serta terkadang masih adanya kondisi dressing yang kurang baik. Pemilihan area pemasangan infus sudah mengalami peningkatan, maintenance luka tusukan infus juga mulai dilakukan oleh petugas, sehingga jika terjadi phlebitis bisa diketahui lebih dini tidak sampai grade yang tinggi dan segera dilakukan pemasangan infus ulang dengan tempat yang berbeda. Pemasangan infus juga banyak dilakukan oleh tenaga perawat dengan PK 1 dan PK2.				
RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle phlebitis.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	Kepatuhan bundle phlebitis tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	- Monitoring kepatuhan 5 moment cuci tangan. - Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus. - Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus. - Monitoring penyuntikan yang aman. - Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic. - Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat. - Mengingatkan kembali petugas untuk menyiapkan minimal 1 kapas alcohol swab saat menyiapkan injeksi pada wadah injeksi masing-masing pasien agar tidak lupa untuk melakukan desinfeksi tubing selang sebelum injeksi melalui selang infus.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/PCN	Satu bulan

3.3 Fasilitas Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

3.3.1 Fasilitas Kesehatan

Tabel 3.3.1 Fasilitas Kesehatan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan Bulan TW 2 2026
1	Pemeliharaan alat	-
2	Kalibrasi	-
3	Penambahan alat	-
4	Monitoring Kesehatan	a. Pemenuhan gizi karyawan tetap dilakukan dengan pemberian makan pada karyawan setiap Jumat pagi dan pemberian extra fooding pada perawat IRNA isolasi dan petugas radiologi. b. Pada bulan ini juga masih berlangsung pemberian buka puasa bagi karyawan yang menjalankan ibadah puasa sunnah. c. Pada bulan ini tidak dilakukan pemberian vaksin maupun vitamin pada karyawan. d. Pemeriksaan kesehatan karyawan untuk tahun ini sudah dilaksanakan pada akhir bulan ini dan sedang dibuatkan laporan hasil oleh tim K3RS.
5	Pembangunan dan renovasi	- Tidak ada proses renovasi

3.3.2 Keselamatan Kerja (Manajemen Resiko)

Tabel 3.3.2 Kejadian Keselamatan Kerja (Manajemen Resiko)

No	Jenis Kejadian	Ringkasan
1	Kejadian terkena benda tajam (pajanan)	- Terjadi kejadian terkena benda tajam (pajanan) bulan ini sebanyak 2 kejadian dimana satu petugas kebersihan dan yang satu adalah perawat IGD. Hal ini disebabkan masih kurang patuhnya staf dalam pembuangan limbah benda tajam pada safety box, tidak patuhnya pemakaian APD saat pengambilan limbah di unit. Namun demikian dari kejadian tresebut sudah dilakukan pertolongan pertama yaitu dengan membilas dengan air mengalir dan didesinfektan menggunakan alkohol swab. Karena limbah benda tajam tersebut juga belum jelas pada pasien apa dengan diagnosa apa jadinya perlu dilakukan pemantauan lebih lanjut, diagendakan pemeriksaan laboratorium sekalian dengan MCU rutinan karyawan yang ada di RS.

3.3.3 PKRS

Tabel 3.3.3 Kegiatan PKRS Komite PPI RS Prima Husada Malang

No	Kegiatan PKRS	Ringkasan Pelaksanaan Kegiatan
1	Kegiatan sosialisasi dan edukasi kelompok pasien dan keluarga	- Kegiatan edukasi kelompok pada bulan ini memenuhi 10x edukasi.

		- Kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang PPI (kebersihan tangan, etika batuk, Pemakaian APD, PHBS) kepada pasien, keluarga dan pengunjung secara berkala oleh anggota Komite PPI dengan koordinasi dengan Tim PKRS. Edukasi kelompok paling banyak dilakukan di ruang koridor rawat inap dan ruang tunggu rawat jalan.																																				
Jumlah peserta yang dididikasi: 80 Periode pelaksanaan (1) - Nama Unit - Tahun: 2026 (1) - <table><thead><tr><th>Period...</th><th>Tanggal...</th><th>Nama U...</th><th>Nama Ed...</th><th>Judul/Topik...</th><th>Ju...</th><th>Foto 1</th><th>Foto 2</th><th>Daftar Hadir</th></tr></thead><tbody><tr><td>06 JUN 2026</td><td>30 Jun 2026 14.00.00</td><td>ICU</td><td>septian</td><td>etika batuk</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06 JUN 2026</td><td>22 Jun 2026 10.00.00</td><td>IRNA 4A</td><td>nandini</td><td>Penggunaan APD dan Etika Batuk Kode/Nomer Leaflet: UM / 007</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06 JUN 2026</td><td>15 Jun 2026 10.00.00</td><td>IRNA 3A</td><td>wahia</td><td>Penggunaan APD dan Etika Batuk Kode/Nomer Leaflet: UM / 007</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Period...	Tanggal...	Nama U...	Nama Ed...	Judul/Topik...	Ju...	Foto 1	Foto 2	Daftar Hadir	06 JUN 2026	30 Jun 2026 14.00.00	ICU	septian	etika batuk	10				06 JUN 2026	22 Jun 2026 10.00.00	IRNA 4A	nandini	Penggunaan APD dan Etika Batuk Kode/Nomer Leaflet: UM / 007	5				06 JUN 2026	15 Jun 2026 10.00.00	IRNA 3A	wahia	Penggunaan APD dan Etika Batuk Kode/Nomer Leaflet: UM / 007	5			
Period...	Tanggal...	Nama U...	Nama Ed...	Judul/Topik...	Ju...	Foto 1	Foto 2	Daftar Hadir																														
06 JUN 2026	30 Jun 2026 14.00.00	ICU	septian	etika batuk	10																																	
06 JUN 2026	22 Jun 2026 10.00.00	IRNA 4A	nandini	Penggunaan APD dan Etika Batuk Kode/Nomer Leaflet: UM / 007	5																																	
06 JUN 2026	15 Jun 2026 10.00.00	IRNA 3A	wahia	Penggunaan APD dan Etika Batuk Kode/Nomer Leaflet: UM / 007	5																																	
2	Edukasi melalui media audiovisual.	- Dilakukan edukasi kelompok dengan penayangan video edukasi cuci tangan di ruang tunggu poli dan farmasi dan sampai saat ini masih terus dilakukan dengan jeda waktu pemutaran video sekitar 30 menit sekali. (25 x tayang /hari) Namun saat ini berkurang karena adanya tambahan video edukasi lainnya menjadi 60 menit sekali penayangan atau 12x /hari.																																				
3	Edukasi pasien di RM	- Edukasi ini masih belum berjalan rutin dengan baik, penggunaan ERM terkait lembar edukasi membuat keterisian lembar edukasi terkait hand hygiene dan etika batuk berkurang. Saat dikonfirmasi ke pasien (6 dari 10 pasien memang belum diberikan edukasi, sisanya hanya diingatkan untuk sering melakukan cuci tangan dengan melihat stiker HH yang ditempel di bed).																																				
4	Kegiatan sosialisasi dan edukasi PPI kepada staf	- Dilakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang PPI (kebersihan tangan, etika batuk pemakaian APD, dan pemilahan sampah) kepada sesama staf oleh anggota Komite PPI pada saat jam dinas, kegiatan edukasi oleh PPI berjalan di unit-unit pelayanan. Dokumentasi kegiatan dikoordinasikan juga dengan tim PKRS.																																				
Bukti dokumentasi sosialisasi:		- https://sites.google.com/view/komite-ppi-rs-prima-husada/kegiatan-ppi/sosialisasi-ppi/sosialisasiedukasi-kelompok																																				

IV. Time Scedule

4.1 Evaluasi Jadwal

[illegible]

No	KEGIATAN	Jan 2026				Feb 2026				Mar 2026				Apr 2026				Mei 2026				Jun 2026			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
3	Monitoring Mutu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Surveilans	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Audit program PPI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Pemeriksaan fisika & biologi air bersih dan air minum	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-
7	a. Rapat bulanan PPI.	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
	b. Koordinasi dengan manajemen. (Morning Report)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	c. Rapat Triwulan PPI dengan komite Mutu, dan komite lainnya.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pemeriksaan uji lingkungan (Ambien udara)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-

I. PENUTUP

Dari hasil monitoring dan evaluasi perlu ditingkatkan kembali kegiatan monitoring supervisi baik dari IPCN maupun koordinasi dari IPCLN dan kepala ruang masing-masing untuk membantu meningkatkan mutu terutama terkait pencegahan infeksi. Adanya monitoring secara berkala dari kepala unit maupun jajaran manajemen di atasnya dapat meningkatkan kepatuhan dari petugas.

Dilaporkan Kepada,
Ketua Komite PPI



dr. Aida Musyarofah, Sp. OG

Malang, 17 Juli 2026
Penyusun,
IPCN



Lusianah Nurul, AMd. Kep

Mengetahui,
Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes